

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN LUKA ROBEKAN PERINEUM GR I-II		
	No. Dokumen 571.49/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Suatu tindakan penjahitan robekan perinium yang terbatas pada kulit dan otot		
Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah di dalam melaksanakan tindakan tindakan penjahitan pada robekan perineum tingkat 1-2.		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan Bidan		
Prosedur	1. Siapkan alat, meliputi : 1. Wadah berisi : sarung tangan, pemegang jarum jahit atau klem , benang jahit, kasa steril dan pinset. 2. Kapas DTT. 3. Buka spuit sekali pakai 10 ml dari kemasan steril, jatuhkan dalam wadah DTT. 4. Kain atau doek steril untuk alas bokong. 5. Lignokain dan WFI secukupnya. 6. Lampu sorot atau lampu senter. 7. Busi nomer 20. 8. Folley kateter sejumlah 1 buah 9. Dekatkan alat disamping pasien 2. Lakukan persiapan klien/pasien 1. Lakukan 5 S (Senyum,Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 2. Perkenalkan diri dan Dokter yang merawat 3. Identifikasi pasien 4. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan 5. Atur posisi pasien dalam posisi lithotomi 3. Siapkan lingkungan 1. Jaga privasi pasien dengan memasang sketsel / sampiran 2. Ciptakan lingkungan yang nyaman dan aman 4. Laksanakan tindakan 1. Cuci tangan 6 langkah 2. Pakai APD sesuai standart 3. Pasang kain atau doek steril dibawah bokong pasien. 4. Minta asisten memeriksa uterus dan memastikan bahwa uterus berkontraksi. 5. Gunakan dan pastikan terlebih dahulu tidak ada alergi terhadap anastesi lokal dengan lignokain.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN LUKA ROBEKAN PERINEUM GR I-II		
	No. Dokumen 571.49/I-SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
Prosedur	6. Periksa vagina, perinium, dan serviks secara cermat. 7. Jika robekan panjang dan dalam, periksa apakah robekan itu derajat 3 dan 4 : a. Masukkan jari yang bersarung tangan ke anus b. Identifikasi sfingter c. Rasakan tonus dari sfingter 8. Ganti sarung tangan. 9. Jika sfingter kena, lakukan perbaikan robekan derajat 3 -4 10. Jika sfingter utuh, lanjutkan tindakan berikutnya 11. Lakukan antisepsis pada daerah robekan. 12. Masukkan jarum pada ujung atau pojok robekan atau luka dan dorong masuk sepanjang luka mengikut garis tempat jarum jahitnya akan masuk atau keluar. 13. Aspirasikan dan kemudian suntikkan sekitar 10 ml lignokain 0,5 % dibawah mukosa vagina, dibawah kulit perineum, dan pada otot – otot perineum. 14. Tunggu 2 menit agar anestesi efektif. 15. Jahit mukosa vagina secara jelujur dengan catgut kromik2-0. Mulai dari sekitar 1 cm diatas puncak luka didalam vagina sampai pada batas vagina 16. Lanjutkan jahitan pada daerah otot perineum sampai ujung luka pada perineum secara jelujur dengan catg ut kromik 2-0. Lihat kedalam luka untuk mengetahui letak ototnya. Penting sekali untuk menjahit otot ke otot, agar tidak ada rongga diantaranya. 17. Carilah lapisan subkutikuler persis dibawah lapisan kulit. 18. Lanjutkan dengan jahitan subkutikuler kembali kearah batas vagina, akhiri dengan simpul mati pada bagian dalam vagina 19. Untuk membuat sampul mati benar – benar kuat, buatlah 1½ simpul mati. Potong kedua ujung benang, dan hanya sisakan masing – masing 1 cm. 20. Jika robekan cukup luas dan dalam, lakukan colok rectal dan pastikan tidak ada bagian rectal terjahit. 5. Rapikan Pasien dan bereskan Alat 1. Rapikan pasien dengan posisi yang nyaman 2. Bereskan alat-alat yang tidak digunakan 3. Lakukan 6 langkah cuci tangan setelah tindakan 6. Lakukan Evaluasi dan Dokumentasi 1. Evaluasi hasil tindakan dan respon pasien 2. Dokumentasi tindakan pada rekam medik pasien		
Unit Terkait	1. Ruang bersalin 2. Instalasi Gawat Darurat		